

Tampilan Field Baru — Form Pendaftaran & Catatan ANC

Panduan visual untuk tim UX · berbasis masukan Bidan Erlyna & Bidan Yessy · Prototype v14 Sep 2026

Isi dokumen

- **Bagian A** — Form Pendaftaran: pola "Riwayat Kebidanan" (4 masukan Erlyna) → **list berulang**, bukan kolom teks
- **Bagian B** — Catatan ANC: Antropometri & Gizi (TB, IMT), Pemeriksaan Janin (Leopold, presentasi/bagian terendah, TBJ), USG, Pemeriksaan Dalam (kondisional)
- **Bagian C** — Analisis/Diagnosa + aturan komponen bersama & tabel spesifikasi
- **Bagian D** — Keputusan yang perlu diambil UX (termasuk opsi struktur SOAP)

Cara pakai: tiap bagian berisi **contoh tampilan** (kiri, dalam lebar layar mobile 360px) dan **alasan/aturan desain** (kanan). Semua warna, radius, dan komponen mengikuti **design token prototype v14 Sep**: primary **#1a73e8** , netral **clay-100/200/300** , radius input 8px, radius kartu 12px, font Plus Jakarta Sans.

Prinsip utama (3 hal)

- **1. Riwayat itu multi-kejadian** — pakai komponen list berulang + tombol "Tambah", bukan 4 kolom teks panjang.
- **2. Jangan tampilkan field kondisional sebelum dipicu** — pemeriksaan dalam & USG muncul setelah toggle = Ya.
- **3. Bedakan hasil pemeriksaan vs kesimpulan** — semua hasil (objektif) di atas, "Kesimpulan/Diagnosa" di paling bawah form.

Pola "Riwayat Kebidanan" — 4 masukan Bidan Erlyna

Riwayat KB · Riwayat Persalinan · Riwayat Kehamilan Terdahulu · Riwayat Pernikahan

CONTOH TAMPILAN

Riwayat Kebidanan opsional

Diisi bila pasien pernah hamil / melahirkan sebelumnya.
Boleh dilewati.

Kehamilan & Persalinan ke-1

Tahun

Usia hamil

2022

39 mgg

Hasil

Lahir hidup

Cara persalinan

Normal

Komplikasi

Tidak ada / tulis bila ada

+ Tambah kehamilan / persalinan

Riwayat KB

Suntik 3 bulan

Mulai

Selesai

03/2024

—

Masih digunakan

+ Tambah riwayat KB

Riwayat Pernikahan

Menikah

Menikah ke-

Usia menikah pertama

1

21 th

Aturan desain

- **Satu komponen, dipakai 3×** — kartu riwayat berulang dengan tombol "+ Tambah". Tiap kartu: Selesai/Dihapus lewat menu (:), bukan tombol besar.
- **Kehamilan & Persalinan digabung jadi satu kartu** (1 kehamilan = 1 hasil). Ini mengurangi input ganda dibanding 2 daftar terpisah — tapi UX boleh memisah bila ingin laporan per-kejadian.
- **Riwayat Pernikahan = single field**, bukan list. Sub-field (menikah ke-, usia menikah pertama, lama) hanya muncul bila status = Menikah / Janda.
- **Letak:** setelah blok G / P / A, di dalam accordion "Riwayat Kebidanan (opsional)" — konsisten dengan accordion "Lengkapi Identitas..." yang sudah ada.
- **Empty state:** pasien primigravida → tampilkan kartu kosong bertulisan "Belum ada riwayat. Tambahkan bila pasien pernah hamil." — jangan sembunyikan seksi.
- **Konsistensi data:** bila G/P/A = 3/2/0 tapi riwayat terisi 1 baris → tampilkan info lembut (bukan blokir): "G3P2A0 · riwayat terisi 1 kejadian. Lengkapi?"
- **Ringkasan collapsed:** saat accordion tertutup, tampilkan chip:

G3P2A0 KB: suntik 3 bulan Menikah

 agar bidan tak perlu buka-tutup.

Catatan untuk UX: keempat riwayat ini masuk kategori **Subjektif (anamnesis)** — bukan data identitas. Kalau nanti form pendaftaran dipecah per langkah, letakkan di langkah **Riwayat Kesehatan**, bukan langkah Identitas.

Antropometri & Gizi — Tinggi Badan + IMT

Masukan Bidan Yessy · TB belum ada di prototype; BB & LiLA sudah ada

CONTOH TAMPILAN

Antropometri & Gizi

Tinggi badan baru

Berat badan

158

cm

62

kg

LiLA

IMT (otomatis)

24

cm

24,8

Normal

LiLA < 23,5 cm → risiko KEK. IMT dihitung otomatis dari TB & BB pra-hamil.

TB otomatis terkunci setelah kunjungan pertama. Ada tombol "Ubah" kecil bila perlu dikoreksi.

Simpan

Aturan desain

- **Tinggi badan masuk grup "Antropometri & Gizi"** — satu grup dengan BB & LiLA, karena ketiganya dipakai untuk skrining gizi. Jangan ditaruh di blok tanda vital.
- **Number input + unit sebagai suffix di dalam kotak** (bukan di label) → mengecilkan lebar dan mencegah salah tulis satuan.
- **IMT dihitung otomatis** (read-only, tampilan dashed) + badge kategori: Kurus / Normal / Gemuk. Bidan tidak perlu menghitung, tapi tetap bisa lihat asalnya (TB × BB).
- **TB hanya diisi sekali** — setelah tersimpan, jadi read-only dengan aksi "Ubah" (bukan input bebas tiap kunjungan). BB & LiLA tetap diisi setiap kunjungan.
- **Urutan dalam grup:** TB → BB → LiLA → IMT. Grid 2 kolom, tinggi field seragam 40px.
- **Keyboard:** numeric pad untuk TB/BB/LiLA; tampilkan koma desimal bila perlu (IMT 1 angka di belakang koma).
- **Validasi lembut** (peringatan kuning, tidak memblokir simpan): TB 120–200 cm · BB 25–150 kg · LiLA 15–45 cm. Bila di luar rentang, minta konfirmasi "Angka ini tidak biasa. Sudah benar?".

Kenapa TB penting: tanpa TB, IMT tidak bisa dihitung — padahal kenaikan BB ideal selama hamil dinilai dari **IMT pra-hamil**. Jadi TB bukan sekadar arsip, tapi **input** untuk penilaian kenaikan BB.

Pemeriksaan Janin — Leopold, Presentasi & TBJ

Masukan Bidan Erlyna · TFU & DJJ sudah ada di prototype

CONTOH TAMPILAN

Pemeriksaan Janin

TFU

DJJ

30

cm

140

bpm

Presentasi / letak janin

baru

Kepala

▼

Bagian terendah janin

baru

Kepala

▼

TBJ

baru

2.450

gram

Estimasi otomatis dari TFU & usia kehamilan.

Ubah manual (hasil USG berbeda)

Catatan Leopold (opsional)

cth: kepala di bawah, punggung kiri

Simpan

Aturan desain

- Yang disimpan adalah **HASIL**, bukan **4 manuver**. Leopold I–IV adalah cara memeriksa; yang perlu tersimpan = **presentasi/letak janin + bagian terendah janin**. Bidan tidak perlu mengisi 4 dropdown manuver tiap kunjungan.
- **Kedua field pakai select** (bukan teks bebas) dengan opsi baku: Kepala · Bokong/Sungsang · Lintang/Melintang · Tidak jelas. Ini menjaga data bisa direkap.
- **Variasi opsional**: bila UX ingin tetap menampilkan Leopold, pakai 4 select ringkas dalam grid 2×2, disembunyikan di dalam “*Catatan Leopold (opsional)*” — jangan di posisi utama.
- **TBJ = number + auto-estimasi**. Tampilkan angka estimasi lebih dulu (read-only), lalu toggle “Ubah manual” bila bidan punya angka dari USG. Sumber angka ikut dicatat (Estimasi TFU / USG) agar tidak ambigu.
- **TBJ hanya relevan mulai ±20 minggu** (TFU > 20 cm). Sebelum itu, tampilkan field nonaktif dengan keterangan “*Belum dihitung pada usia ini*”.
- **Urutan dalam grup**: TFU → DJJ → Presentasi → Bagian terendah → TBJ → Catatan Leopold. Field hasil pemeriksaan raga sebelum catatan.
- **Validasi lembut**: TFU 10–45 cm · DJJ 60–200 bpm · TBJ 200–5.000 gram.

Contoh perhitungan yang diharapkan (untuk tim tech): TBJ (gram) ≈ (TFU – 12) × 155 untuk posisi kepala — cukup sebagai **estimasi default**, selalu bisa ditimpa manual, dan **jangan** dipakai untuk klaim klinis (beri label “estimasi”).

USG & Pemeriksaan Dalam (Kondisional)

Masukan Bidan Yessy (USG + catatan) & Bidan Erlyna (pemeriksaan dalam bila perlu)

CONTOH TAMPILAN — KONDISI "YA"

USG

USG dilakukan?

Tidak

Ya

Tanggal USG

Pemeriksa

14/09/2026

Dokter

Catatan hasil USG

cth: janin tunggal, DJJ +, air ketuban cukup, plasenta fundus

Pemeriksaan dalam

Dilakukan?

Tidak

Ya

Pembukaan serviks

2cm

Ketuban

Utuh

Penurunan / Hodge

Hodge II

Catatan

cth: panggul normal

Simpan

Aturan desain — USG

- **Bentuk final:** satu kartu "USG" dengan segmented **Tidak / Ya**. Prototype sekarang hanya punya penanda + "Catatan hasil USG" — jadikan satu grup yang rapi.
- **Sub-field muncul hanya bila Ya** (Tanggal · Pemeriksa · Catatan hasil). Default **Tidak**, sehingga form tetap ringkas untuk kunjungan tanpa USG.
- **Pemeriksa** dipakai untuk menandai kunjungan dokter (ANC oleh dokter), bisa direkap terpisah.
- **Kolom catatan dibuat tinggi (3 baris)** karena jawabannya naratif; beri contoh isi sebagai placeholder, bukan label panjang.

Aturan desain — Pemeriksaan dalam

- **Wajib kondisional**, bukan field terbuka. Label harus jelas: "Pemeriksaan dalam (bila perlu)" dengan default **Tidak**.
- **Sub-field mengikuti praktik klinis:** Pembukaan serviks (cm) · Ketuban (utuh/pecah) · Penurunan/Hodge · Catatan. Tambahkan **Presentasi** bila perlu, tapi field presentasi sudah ada di grup Pemeriksaan Janin — jangan duplikasi.
- **Hindari istilah yang tidak dipakai bidan** di label: pakai "Pembukaan", bukan "dilatasi serviks"; pakai "Hodge", bukan "station".
- **Kapan dipakai:** ANC umumnya tidak rutin VT (lebih sering di persalinan). Karena itu toggle-nya bisa ditampilkan **di paling bawah** grup pemeriksaan, setelah field non-invasif.

Konsistensi pola: dua field di halaman ini memakai pola yang sama — **segmented Tidak/Ya + blok sub-field kondisional**. Pakai pola yang sama untuk field kondisional lain agar bidan cepat terbiasa.

Kesimpulan / Diagnosa + Aturan Bersama

Masukan Bidan Yessy ("catatan buat diagnosa")

CONTOH TAMPILAN — BAWAH FORM

Kesimpulan / Diagnosa

G2P1A0 hamil 32 minggu, janin tunggal, presentasi kepala, tanpa penyulit

Ambil dari hasil pemeriksaan

Tombol menyusun kalimat otomatis dari field objektif (usia kehamilan, G/P/A, TFU, presentasi, hasil lab). Bidan boleh mengubah.

Catatan tambahan (opsional)

cth: anjurkan kontrol 2 minggu lagi

Simpan

Aturan desain — Kesimpulan/Diagnosa

- **Textarea full-width, di paling bawah form** (setelah semua hasil pemeriksaan) dengan label jelas: "Kesimpulan / Diagnosa". Ini yang diminta Yessy sebagai "catatan buat diagnosa".
- **Jangan digabung dengan "Catatan pemeriksaan"** yang sudah ada — beda fungsi: catatan pemeriksaan = temuan, kesimpulan = analisis.
- **Sediakan tombol "Ambil dari hasil pemeriksaan"** yang menyusun kalimat baku dari data yang sudah diisi (G/P/A, usia kehamilan, TFU, presentasi, lab). Menghemat waktu bidan dan menyeragamkan format catatan.
- **Bahasa label:** pakai istilah yang dipakai bidan — "Hasil/Diagnosis" sudah dipakai di modul Nifas, jadi **samakan penamaannya** agar konsisten antar kartu layanan.

Aturan komponen bersama (semua field baru)

JENIS DATA	KOMPONEN	CONTOH
Angka bersatuan	Number input + unit di dalam kotak	TB 158 cm · TBJ 2.450 gram
Pilihan baku	Select (bukan teks bebas) agar bisa direkap	Presentasi janin · Metode KB · Cara persalinan
Ya / Tidak	Segmented control + blok kondisional	USG dilakukan? · Pemeriksaan dalam?
Multi-pilih	Checkbox	Tanda bahaya nifas (pola existing)
Naratif	Textarea 3 baris + placeholder contoh	Catatan hasil USG · Kesimpulan/Diagnosa
Riwayat berulang	Kartu list + tombol "+ Tambah" + empty state	Riwayat persalinan · Riwayat KB
Layout kelompok	Grid 2 kolom untuk field pendek, 1 kolom untuk naratif	TB/BB · TFU/DJJ

Konsistensi visual: label di atas input · tinggi field 40px · radius 8px · warna border c_{lay}-300 · field wajib bertanda * · field opsional dikelompokkan di accordion "Lengkapi data lain (opsional)" seperti pola prototype saat ini.

Yang Perlu Diputuskan UX

Tiga hal yang menentukan bentuk akhir field baru

1. Struktur form ANC: ikut SOAP atau tetap flat?

- **Opsi A — penuh SOAP:** form dipecah menjadi **Subjektif** (keluhan, riwayat) · **Objektif** (antropometri, tanda vital, pemeriksaan janin, lab, USG) · **Analisis** (kesimpulan/diagnosa) · **Penatalaksanaan** (rencana, jadwal kontrol). Paling sesuai cara bidan berpikir.
- **Opsi B — minimum (rekomendasi awal):** pertahankan form sekarang, tapi kelompokkan ulang jadi blok berjudul + pindahkan "Kesimpulan/Diagnosa" ke paling bawah. Lebih cepat dikerjakan, tidak mengubah kebiasaan.
- **Dampak:** Opsi A mengubah hampir semua urutan form ANC dan perlu penyesuaian di ringkasan WA & laporan; Opsi B hanya menambah grup.

2. Riwayat obstetri: satu kartu gabungan atau dipisah?

- **Gabung (rekomendasi):** 1 kartu = 1 kehamilan + hasilnya (persalinan/nifas). Input lebih sedikit, cocok dengan cara bidan bercerita.
- **Pisah:** daftar "Riwayat Persalinan" & "Riwayat Kehamilan" sendiri-sendiri → lebih rapi untuk laporan, tapi bidan mengisi dua tempat.
- Keputusan ini juga menentukan bentuk **tampilan riwayat di Profil Pasien** (tab ANC/Persalinan/Nifas).

3. Leopold: simpan hasil saja, atau 4 manuver?

- **Hasil saja (rekomendasi):** presentasi/letak janin + bagian terendah janin. Cepat diisi, data bisa direkap.
- **4 manuver:** lebih lengkap untuk pendidikan/dokumentasi, tapi 4 dropdown tiap kunjungan berisiko bikin bidan malas.

Urutan pekerjaan yang disarankan: (1) putuskan struktur form → (2) finalkan komponen riwayat berulang → (3) baru susun tampilan tiap grup. Bila struktur belum final, field-field ini sebaiknya **jangan** langsung dipindah ke desain high-fidelity.